

УДК 616-006.6-08

Г.А.Серикбаев, А.К.Курманалиев, Д.А.Тулеева, Ж.О.Мауленов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы лечения сарком мягких тканей на современном этапе. Приведена доступная информация о применении трабектедина при лечении сарком мягких тканей, которая свидетельствует о его значимой роли.

Ключевые слова: трабектедин, Йонделис, саркомы мягких тканей, оперативное лечение, химиотерапия.

Гетерогенную группу редких злокачественных опухолей мезенхимального происхождения обозначают термином "саркомы мягких тканей". В настоящее время различают более 50 гистологических подтипов сарком мягких тканей, ввиду сходства их гистопатологических характеристик, клинических проявлений, а также течения опухолевого процесса. Они составляют 1,2-2,6% в общей структуре злокачественных новообразований человека. Почти все злокачественные опухоли мягких тканей являются сарcomaми, которые составляют 0,7% всех злокачественных опухолей человека.

В Республике Казахстан абсолютное число вновь выявленных заболеваний в 1993 г. составило 235, в 2002 г. – 192.

Чаще всего эти опухоли отмечаются у людей в возрасте 20-50 лет. У детей – они составляют 10-11%. Преимущественная локализация сарком мягких тканей – конечности (до 60%), причем около 46% – нижние конечности и 13% – верхние. На туловище эти опухоли локализуются в 15-20% случаев, на голове и шее – в 5-10%. На забрюшинное пространство приходится 13-25% [1].

Основным методом лечения у данной группы пациентов является оперативное лечение. Однако, необходимо включение в программу лечения химио- и лучевой терапии, являющиеся дополнительным методом лечения.

Проведенный метаанализ (2008) 1568 больных из 14 клинических исследований, показал абсолютное преимущество адъювантной терапии в 6% случаев для локального безрецидивного интервала и в 10% - для появления отдаленных метастазов. Десятилетней выживаемости пролеченных больных

выявлено не было. Вероятно, низкие показатели эффективности связаны с тем, что при подсчете результатов не учитывался гистологический подтип опухоли.

В последнее время появляются новые лекарства и возможные их комбинации. Приобретает клинические перспективы таргетная терапия, которая стабилизирует процесс с удлинением выживаемости, что является основной целью при использовании таргетных препаратов [2].

Проблему местного рецидивирования можно решить, применяя локальные методы воздействия на опухоль: различные методы и режимы дистанционной лучевой терапии, регионарная химиоперфузия, брахитерапия, интраоперационная лучевая терапия (Алиев М.Д., 2004).

Общепринятым подходом к лечению сарком мягких тканей в настоящее время являются органосохраняющие оперативные вмешательства с обязательным дополнением операции лучевой терапией в той или иной последовательности их применения. Это обеспечивает уровень локального контроля, сопоставимый с таковым при выполнении обширных вмешательств (ампутации, удаление мышечной группы и т.д) и составляет 80-90%. В свете общей тенденции современной онкоортопедии к органосохраняющему лечению при обязательном соблюдении принципов радикализма, в отношении сарком мягких тканей данный подход к лечению чрезвычайно актуален, т.к. до 60% СМТ поражают конечности.

Несмотря на то, что комбинированный подход к лечению с применением гамма-терапии и достиг определенного уровня в обеспечении локорегионарного контроля и общей выживаемости, эти результаты нельзя назвать удовлетворительными. Так как проблемы местного рецидивирования и отдаленного метастазирования, а, следовательно, и общей выживаемости не сведены к минимуму, а смертность остается по-прежнему на высоком уровне. Кроме того, не менее актуальной является проблема органосохраняющего оперативного лечения, ввиду того, что более 1/3 заболевших – это лица молодого трудоспособного возраста (моложе 30 лет), что не менее важно как в морально-этическом, так и в социально-экономическом плане [3].

В этой связи целесообразен поиск методов оптимизации комбинированной терапии, которая снизила бы риски местного рецидивирования и отдаленного метастазирования. С учетом вышеизложенного, целью настоящей статьи является описание результатов курсового лечения таргетным препаратом трабектедином в структуре комбинированной терапии СМТ.

Препарат Трабектедин - представляет собой алкалоид природного (морского) происхождения, впервые выделенный из Карибского оболочника *Ecteinascidia turbinata*. Успех Трабектедина в предварительных крупных клинических рандомизированных испытаниях III фазы при лечении сарком мягких тканей, привел к утверждению препарата во многих странах [4].

Клиническая эффективность Трабектедина исследовалась в рамках 3 нерандомизированных (Европа и США)

и одного рандомизированного исследования (Европа, США, Россия) II фазы у пациентов с распространенными саркомами мягких тканей. В них принимало участие более 450 пациентов с различными типами диссеминированных сарком мягких тканей, с прогрессированием заболевания после 1-й и более линий химиотерапии. При использовании препарата в качестве 2-й линии химиотерапии больных с распространенными и нерезектабельными саркомами мягких тканей медиана выживаемости составила

10,3 месяца, а 2-летняя выживаемость – около 30% [5].

Трабектедин стал единственным, не имеющим аналогов, препаратом, зарегистрированным для лечения распространенной саркомы мягких тканей, с хорошим профилем безопасности и эффективности. Трабектедину присвоен статус органного лекарственного средства в Европе и США[6].

Комплексное лечение проведено в период с 2012-2015гг. 61 пациенту (таблица 1,2,3):

Таблица 1-Характеристика больных

Женщины – 40 (65%)		Мужчины – 21 (35%)	
20-50 лет – 42 человека (68%)		50 лет и старше – 19 человек (32%)	
StI – 3 (4,9%)	StII – 19 (31,2%)	StIII – 33 (54,1%)	StIV – 6 (9,8%).

Таблица 2 -Локализации опухолей

Локализации опухолей	Кол-во, %
Нижние конечности	42,5
Ягодичная область и таз –	18%
Верхние конечности –	13%
Спина –	8,2%
Грудная стенка – 8,2%	8,2%
Шея -	6,5%
Другие локализации –	3,6%

Таблица 3 - Основные гистологические подтипы

злокачественная фиброзная гистиоцитома	24,5
липосаркомы	13,1
фибросаркомы	11,4
рабдомиосаркомы	9,8
саркомы Юинга	6,55
шванномы	6,55
альвеолярная рабдомиосаркома	6,5
синовиальная саркома	4,9
другие типы	16,7

Оперативное лечение получили 12 (19,6%) пациентов, оперативное лечение + адъювантная химиотерапия - 19 (31,2%), неоадъювантную химиотерапию + оперативное лечение + адъювантная химиотерапия получили 30 (49,2%) пациентов.

При этом основным методом вмешательства являлось оперативное лечение в объеме – футлярное удаление опухоли с отступом от 3-6см в зависимости от локализации опухоли. Всем пациентам были проведены радикальные органосохраняющие операции. Количество послеопераци-

онных осложнений составило 2(3,5%).

Лучевая терапия проводилась 5 (8,1%) пациентам в послеоперационном периоде при крае резекции R1. В условиях ЦОКМТиМ лучевая терапия не применялась в неоадъювантном и самостоятельном режимах. Осложнений общих и местных после проведения лучевой терапии не наблюдалось.

При проведении химиотерапии применялись стандартные режимы полихимиотерапии: VAI, VAC, IE, CYADIC, CYVADIC, GemTax.

Таблица 4 - Результаты лечения

Результаты лечения	Количество больных	Период наблюдения
Наблюдение после окончания лечения	20 (32,7%)	1-4 года
Стабилизация процесса при наличии мтс (легкие)	18 (29,5%)	1-4года
Умерло	15 (24,5%)	1-4 года
Рецидив	3 (4,9%)	1-4 года
Продолжают лечение	5(8,4%)	1 год

Как следует из таблицы 4, более чем в 70% случаев отдаленные результаты терапии в послеоперационный период были положительными.

Таблица 5 - Осложнения в результате лекарственного лечения

Вид осложнения	Количество больных	Степень
Нейтропения	15	1-2 степень – 11 3-4 степень - 4
Анемия	10	1-2 степень – 4 3-4 степень - 6
Тромбоцитопения	3	1-2 степень - 3
Эмитогенные явления	27	
Нейротоксичность	3	
Временное ухудшение зрения	2	

Как следует из таблицы 5, трабектедин обладает гораздо более благоприятным профилем безопасности по сравнению со стандартными ЛС, используемыми для лечения СМТ.

В качестве 3-4 линии лечения различных гистологических подтипов сарком мягких тканей, в монорежиме, был применен таргетный препарат трабектедин.

Клинический случай 1.Пациентка И. 1948г.р.Диагноз: множественные метастазы лейомиосаркомы в кости скелета без первично – выявленного очага StIV (TxNoM1). Состояние после открытой биопсии, 10 курсов ПХТ. Прогрессирование процесса. Состояние после 10 курса таргетной терапии. Частичная регрессия процесса.Результаты обследований показаны в таблице6.

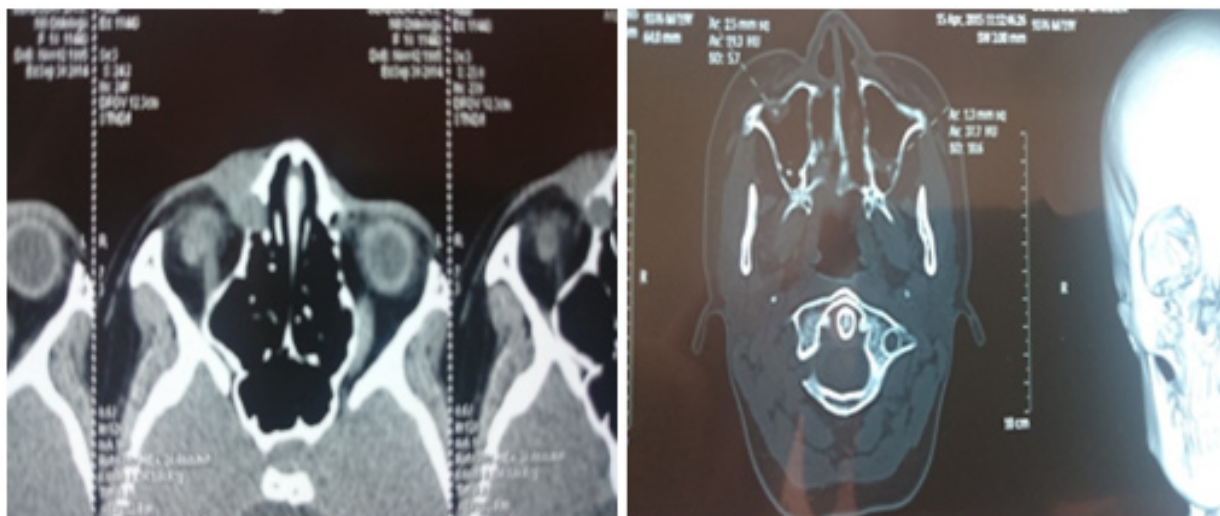
Таблица 5 - Осложнения в результате лекарственного лечения

Показатели	Значения
мтс в легких	4,8>13,8мм
в парамедиастинальной области	13,5>23,13мм
мтс в надпочечниках: левый правый	27,9>5,7мм 7,7>4,1мм
первичная опухоль в голени без изменений	2,0>1,9см
мтс в костях: правая половина крестца	2,4>1,9см
хрящевой конец 2го ребра справа	2,1>1,7см
тело L3	13,1>2,6мм
правое ребро не определяется	11,1см >
правая седалищная кость не определяется	3,0см >

Таким образом, на фоне терапии имело место частичная регрессия метастазов опухоли.

Клинический случай 2. Пациентка Б., 19л., диагноз: Лейомиосаркома мягких тканей скуловой области справа

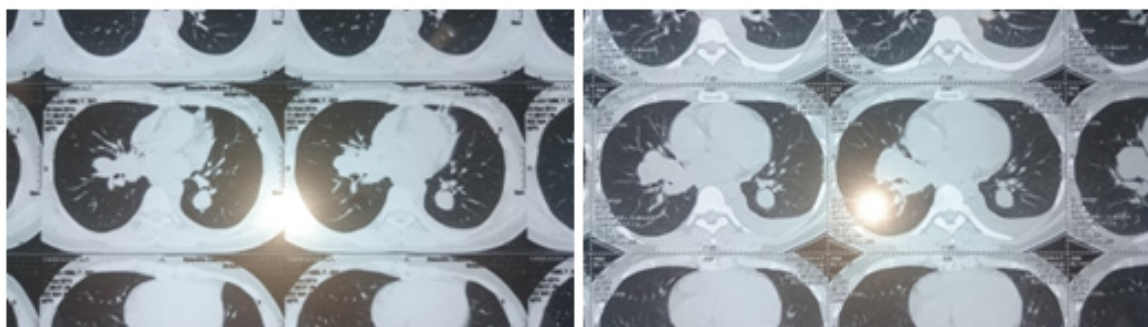
St II(T2aN0M0). Пациент получал 6 курсов химиотерапию препаратом трабектедин. Регрессия процесса со стабилизацией в течение 7 месяцев применения терапии трабектедином.



Снимок 1 - отчетливо видна частичная регрессия.

Клинический случай 3. Пациентка Т., 25л. Диагноз: Альвеолярная саркома мягких тканей бедра справа St III

(T2bN0M0). Метастаз: поражение легких. Стабилизация в течение 9 месяцев.



Снимок 2 - саркома мягких тканей бедра справа.

В 3-х случаях после 3-4 курсового лечения таргетным препаратом стабилизация процесса наступала в период от 11 мес. до 4 лет (таблица 6).

Таблица 6 - Результаты курсового лечения трабектедином

данные пациента	диагноз	кол-во курсов таргетной терапии	стабилизация процесса в течение:
А.Н. 31г.(муж)	«Липосаркома мягких тканей ягодичной области слева StII(T2N0M0). Состояние после оперативного лечения. Рецидив. Состояние после хирургического лечения.	4	4-х лет
С. 50л (жен)	Липосаркома мягких тканей бедра справа StIII (T3N0M0) G1. Состояние после хирургического лечения.	3	15 мес
Т. 47л (жен)	«Липосаркома мягких забрюшинного пространства St IV (T4N1M0). Состояние после операции.	3	11 мес

Выводы. Таким образом, проблема сарком мягких тканей ввиду своей высокой злокачественности, сложной диагностики, трудности в лечении остается одной из самой сложных проблем, требующих мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и применении всех воз-

можных эффективных методов лечения. Согласно накопленным клиническим данным и рецензируемым статьям, трабектедин обладает достаточной эффективностью и хорошей переносимостью, и активен при сарcomaх мягких тканей.

Список литературы

1. Протоколы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Саркомы мягких тканей, 2012.
2. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний /под редакцией Н.И. Переводчиковой, В.А. Горбуновой.- М., 2015.
3. Отт П.А. Комбинированное лечение сарком мягких тканей с применением интраоперационной лучевой терапии, 2014.
4. Bradley J. Petek, Elizabeth T. Loggers, Seth M. Pollack and Robin L. Jones .Trabectedin in Soft Tissue Sarcomas // Mar. Drugs.- 2015.- № 13.- P. 974-983.
5. Горбунова В.А., Феденко А.А. Трабектедин: новые возможности химиотерапии диссеминированных сарком мягких тканей // Реферативный журнал «РМЖ».- 2009.- Т. 17.- № 9. www.rmj.ru/articles_6544.htm
6. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology // Soft Tissue Sarcoma.- 2015.- Vol.2. 2015/- MS-7.

Тұжырым

Г.А.Серикбаев, А.К.Курманалиев, Д.А.Тулеуова,
М.Ж.Мауленов

Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты

Жұмсақ тін саркомасын кешенді емдеу нәтижелері

Осылайша, жұмсақ тін саркомасының мәселесі өзінің өте қатерлі болуына байланысты, қиын диагноз қою, емдеу кезіндегі туындайтын қиындықтарға байланысты өте күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Осыған байланысты, диагноз қою кезінде жан-жақты талдауды, емдеу кезінде мүмкін болатын тиімді емдеу әдістерін қолдауды талап етеді. Жинақталған клиникалық мәліметтерге және рецензияланған мақалаларға сәйкес трабектедин айтарлықтай тиімді және жақсы көндігу қабілеттілігімен және жұмсақ тін саркомасына қарсы белсенді әсер етеді.

Түйінді сөздер: трабектедин, Йонделис, жұмсақ тін саркомасы, ота емі, химиотерапия.

Summary

G.A.Serikbayev, A.K. Kurmanaliyev, D.A. Tuleuova,
Zh.O. Maulenov

Kazakh Research Institute of Oncology & Radiology

Results of complex treatment of the soft tissue sarcomas

Thus, problem the soft tissues of sarcomas in view of the high malignancy, difficult diagnostics, and difficulty in the treatment remains one of the most complex problems which are demand multidisciplinary approach in diagnostics, treatment and application of all possible effective methods of treatment. According to the accumulated clinical data and peer-reviewed articles, trabectedin is sufficiently effective and well tolerated, and active in the soft tissue sarcoma.

Key words: trabectedin, Yondelis, soft tissue sarcoma, surgery, chemotherapy.